



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : مها سيد حسن على

العنوان : عرب العيايده

الحي / المدينة : الخانكة

المحافظة : القليوبية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 26703311401342 رقم التليفون : 01017125875

العمر (تاريخ الميلاد) : 31-03-1967 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مها سيد حسن علي National ID: 26703311401342	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Dms
 صوتي الاصيلي
 هوية صوتي ٨ رجا ٥ والقبولي
 ١١

Request No : 13003134
Request Date : 15/07/2024
Verification Date : 05/08/2024
Financial Category : 224 - 224
Department : Child Patient
Registered By : Mrs Mayanta Thapa

Final Data Report/Investigative
Reference Specimen: Duodenal biopsy, collected at 11/07/2024
Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted
Sections prepared from paraffin block for immunostaining using Leica Mark ULTRA
system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-
9).

Grade (to differentiation): nuclear pleomorphism, mitosis: 13/20 (13/20)

IF (Positive control showed appropriate reactivity)
C: Calcium: Strong diffuse positive
FR: Strong positive

FR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (Score 2+).

20% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Right breast mass. Tru-cut biopsy:
invasive duct carcinoma, Grade II
DCIS

- ER Positive (score 3+)

Dr. Sagna Fikru

Prüfung B3: 10.000,00 €

$$R_{\text{max}} N_{\text{max}}(t) = \text{First Time } R_{\text{max}}(t) \geq N_{\text{max}}(t) \quad (19)$$

Patient Name: [Name]
Patient No.: 2670331461942
Date No.: 240624
Sex: Female
Age: 57 Y
Referring Doc: [Name]

Request No.: 13003131
Request Date: 15/07/2024
Verification Date: 05/08/2024
Financial Category: Out Patient
Department: [Name]
Registered by: [Name]

Pathology Report

ER: Positive (score 6/6)
HER2: (score 1+)
HER2: Positive in 20% of tumor cells.

Scoring system "ER, PR"

ASCO CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faintly perceptible within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faintly perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Comment: Although Her2 is Negative, such cases (Score 1+) are predictive of response to Her2 Ab drug conjugates (ADCs) according to latest 2023 ASCO-CAP guidelines.

Signature
Dr. Walaa Ghonima
Dr. Sagda Elkady



Verified by
Dr. Sagda Elkady

Printing Date: 06/08/2024 09:11:09

Page 2 of 3

Printing By: [Name]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Sahana Cancer Hospital
Radiology Department

Date : 06/08/2024

Age : 57 Year(s)
Pat ID: 65156

Patient Name: Maha Sayed Hassan Ali
Aldkhakhi
Exam : X-RAY CHEST
Medical ID: 2552/2024

Plain X-ray Chest (PA view) revealed:

- Clear both lung fields
- Clear both costo-phrenic angles
- Normal cardiac size & configuration

Best regards

Dr/Dina Gaber FRCR

Not Approved



الوزارة
المركز الطبي
مركز دار السلام
إشعاع

Date : 06/08/2024	Patient Name: Maha Sayed Hassan Ali Alakhakh
Age : 57 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN & PELVIS
Pat ID: 65159	Medical ID: 2552/2024

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged in size (about 19 cm at the right MCL), smooth outline, bright echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent.

Gall Bladder: -

- Is not seen
- CBD is not dilated

Spleen: -

- Average size (About 12 cm), displaying homogenous echopattern

Kidneys: -

- Are of normal size and site, normal echogenicity, no stone or backpressure changes, no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed: -

Uterus: - Is surgically removed

No free fluid in the Douglas pouch.

Opinion:

Bright hepatomegaly

Best Regards,
Dr. Pina Gaber, FRCR,

Not Signed

Patient Name: Maha Sayed Hassan Ali Aldkhakhni	Date: 15/06/2025
Exam: MAMMOGRAPHY BOTH	Age: 58 Year(s)
Medical ID: 2552/2024	Pal. ID: 65150

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after right conservative surgery.

- **Breast density:** Predominant fatty tissue ... *Matching ACR A.*
- Thickened right breast skin with focal asymmetry is seen in the right upper outer quadrant.
- No detected definite suspicious masses, architectural distortion or pathological calcifications in the left breast.
- Normal skin and nipple in the left breast.

Complementary bilateral breast ultrasound:

- Heterogeneous (predominantly fatty) parenchymal echo texture.
- Thickened right breast skin (4 mm).
- Clear right operative bed with clear right axillary scar. No suspicious masses.
- No detected suspicious solid or cystic masses in both breasts.
- No detected significant axillary lymph nodes.

CONCLUSION:

- Post conservative surgery changes of the right breast (BIRADS 2 Category).
- Normal left breast (BIRADS 1 Category).

Much Obligated

DR. MONA ZAKY.MD

Professor of diagnostic radiology-Breast Imaging unit-Mansoura University

Signature Dr. Mona Zaki

15/06/2025 2 24 PM